Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 28ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº **0126841-03.2023.8.17.2001**

AUTOR(A): JOAO PEREIRA FEITOSA

RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

SENTENÇA – extinção com resolução do mérito

Vistos etc.

JOAO PEREIRA FEITOSA propôs AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE FAZER contra CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, afirmando que é segurado do plano de saúde e se encontra com sua mensalidade em dia.

Aduz o autor que é paciente diagnosticado com câncer – MIELOMA MULTIPLO, CID-10 C90.0, diagnosticado em junho de 2023.

Desta forma, o médico responsável, requisitou o início do tratamento com LENALIDOMIDA (REVLIMID), DARATUMUMABE E DEXAMETASONA, os quais devem ser iniciados imediatamente diante da gravidade da doença que acomete a parte autora.

No entanto, o medicamento LENALIDOMIDA (REVLIMID) não foi autorizado, apesar de solicitado pelo médico assistente.

Diante da negativa da seguradora, veio a Juízo requerer em tutela de urgência a cobertura securitária e o integral custeio do tratamento da moléstia que o acomete, em especial o medicamento supracitado.

Juntou vários documentos, dentre eles laudos, carteira do plano, estudos clínicos, exames e outros.

Despacho deferindo a gratuidade e intimando a demandada a se manifestar sobre o pedido de antecipação de tutela, a ré se manifestou no id. 148556011.

Concedida a tutela de urgência (Decisão ID 149137192).

Posteriormente, a Demandada deduziu sua defesa através de Contestação (ID 151449027), com documentos (id. 151449029 - (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam) a 151450837 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam)).

Réplica no ID 160882929.

Os autos me foram apresentados.

É O QUE IMPORTA RELATAR. PASSO À DECISÃO.

O caso é de julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, sendo despicienda a prova técnica pericial requerida pela Ré, já que a prova documental constante nos autos é suficiente para a solução da lide.

Deste modo, as versões dos fatos que constroem a causa de pedir da prestação jurisdicional e a tese da defesa já se apresentam suficientemente claras e enunciadas, a partir do teor das peças atrial, de bloqueio, de réplica e das provas documentais figurantes no bojo dos autos eletrônicos, sobretudo os diversos laudos médicos assinalados pelo médico que assiste a parte autora.

Pois bem, analisando o álbum processual, afere-se que a demandante submeteu ao crivo deste Juízo o presente feito com o fito de compelir o demandado a custear os medicamentos precritos por seu médico LENALIDOMIDA (REVLIMID), DARATUMUMABE E DEXAMETASONA, em razão de ter sido diagnosticado com câncer.

Visando subsidiar os argumentos expendidos acostou os documentos de ID's n. 147427344 a 147427363.

Consoante outrora asseverado, a demandada, devidamente citada para angularizar a relação processual, deduziu a contestação de (ID 151449027), com documentos (id. 151449029 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam)a 151450837 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam)).

Preliminarmente impugnou a justiça gratuita em prol do autor. No mérito, pleiteou pela improcedência dos pedidos autorais, alegando, para tanto, que a cobertura pretendida pelo autor, consistente no fornecimento de medicamento, não está contemplado no rol da ANS, e também ausência de cobertura contratual, motivo pelo qual foi negada a autorização.

Pugna pela taxatividade do rol da ANS. Argumenta a não ocorrência de danos morais, e pede a improcedência da ação.

No que tange a **impugnação à concessão das benesses da gratuidade judiciária** do demandante, rejeito, posto que este, quando do ingresso em juízo, acostou aos autos declaração de hipossuficiência, e ainda comprovação do valor mensal auferido (id. 147427346), comprovando não possuir condição hodierna de arcar com os custos do processo sem comprometer o seu sustento e de sua família, a qual goza de presunção juris tantum e não fora devidamente refutada pela parte contraria.

Nesse ínterim, é de se relevar, ainda, que a condição de necessitado não pode ser medida com instrumento de precisão, sendo de reconhecer que nem sempre a realidade patrimonial reflete a situação financeira do requerente, cedendo, em princípio, à afirmação do postulante de não possuir condição econômica para arcar com as despesas processuais.

Não havendo outras questões preliminares a serem resolvidas, passo a análise do mérito.

Verifica-se que, quanto à matéria de mérito, que as justificativas apresentadas pela empresa-ré não têm como serem aceitas.

A parte autora noticiou a recusa da ré em custear o tratamento medicamentoso pela justificativa da não previsão contratual e ausência de cobertura obrigatória no rol da ANS.

A recusa da demandada destoa da finalidade do contrato, relacionado com a saúde e, portanto, com a própria vida, direitos que integram os "direitos fundamentais" protegidos pela Constituição Federal.

O laudo detalhado exarado pela médica que assiste a parte autora (Id. 147427348) é claro ao assentar a necessidade de submissão ao tratamento com o medicamento LENALIDOMIDA (REVLIMID), DARATUMUMABE E DEXAMETASONA, diante do diagnóstico de **câncer – MIELOMA MULTIPLO, CID-10 C90.0**.

Os elementos que constam dos autos, em especial, a defesa oferecida, realmente indicam que houve recusa por parte do réu em liberar o medicamento indicado pelo médico, sob o argumento de que não foram cumpridas as diretrizes de utilização prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (id. 147427349).

O réu alegou, em sua defesa, que em análise realizada, o Autor não é elegível ao uso do medicamento Lenalidomida.

Ora, totalmente abusiva a negativa da ré, que ainda quer substituir a opção terapêutica recomendada ao autor, pela que entende correta.

O tratamento a ser desenvolvido, exames e a técnica utilizada **devem ser discutidos pelo médico e paciente sem a interferência do convênio médico**, desde que respeitados os limites previstos no contrato e a utilização de medicamentos devidamente aprovados pela Anvisa e recomendados pela Agência Nacional de Saúde.

No caso dos autos, o réu não juntou documento capaz de comprovar a ausência de aprovação do medicamento pelas autoridades brasileiras. Ao contrário, apenas justifica a sua recusa pelo fato de não ser obrigatório.

Ocorre que a ausência de obrigatoriedade não é causa suficiente para a recusa na medida em que compete ao réu arcar com os valores destinados ao diagnóstico e tratamento, desde que devidamente liberados pela Agência Nacional de Saúde, tal como ocorre no caso.

Se a patologia, no caso a reparação do trauma sofrido, está prevista no contrato, não pode haver negativa ou qualquer mitigação quanto ao procedimento recomendado pelo médico quando da avaliação do paciente.

A Lei nº 9.656, de 1998 deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), **exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais e para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos** (art. 12, inciso I, alínea "c", e inciso II, alínea "g").

Ora, o caso dos autos trata justamente da exceção prevista na Lei citada, pois portador de neoplasia maligna, e portanto, não há o que se discutir acerca da obrigatoriedade de fornecimento do referido medicamento, ainda que de uso domiciliar.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento requisitado pelo médico. Confira-se:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-SCAN. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes" ( AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Ministro

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). 2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada, por parte da operadora do plano de saúde, de cobertura para tratamento do segurado, com abalo emocional reconhecido, justificadamente, pela instância ordinária, como no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de realização de procedimento e exames prescritos para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1962572 SP 2021/0274369-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento do medicamento succinato de ribociclibe (Kisqali), necessário para tratamento oncológico. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" ( AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma,

julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário 3. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. Precedentes. 4. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2030294 MS 2021/0373400-7, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DO COLO DO ÚTERO. USO DE PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO. NEGATIVA INDEVIDA. ABUSIVIDADE.DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A recomendação para a utilização do medicamento é do profissional que detém o conhecimento técnico sobre o melhor tratamento a ser adotado, não cabendo às operadoras substituírem os técnicos neste mister, sob pena de se pôr em risco a vida do consumidor. 2. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, devendo apenas ser registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente. 3. É abusivo o ato que negou à consumidora o direito a ter o medicamento antineoplásico indicado pelo seu médico assistente, devendo o plano de saúde indenizar em danos morais. 4. Considerando a função educativo-punitiva da indenização por danos morais, a extensão do dano e as variáveis

do caso concreto, é razoável a fixação da verba compensatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso não provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0032100-39.2021.8.17.2001, em que figura como Apelante Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico, e, como Apelada Suemi Kaneko Lindoso, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator. Recife/PE, data da assinatura digital. SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO Desembargador Relator

(TJ-PE - AC: 00321003920218172001, Relator: JOAO JOSE ROCHA TARGINO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

A ré, ao negar o fornecimento do medicamento, ofende o padrão de confiança e lealdade que deve orientar as relações jurídicas, age com comportamento ilícito, abusando de seu poder e frustrando as legítimas e justas expectativas da autora.

De fato, tolerar a conduta de feição negativa da ré equivale a ignorar a essencialidade do objeto do contrato e o conteúdo social deste, idealizado para a tutela adequada da pessoa humana, tornando sua existência mais digna.

Compactuar com a recusa manifestada pela ré corresponde a atenuar o compromisso e a responsabilidade por ela, contratual e legalmente, assumidos, deixando a parte autora de mãos atadas, em situação de exagerada desvantagem, incompatível com o princípio da boa-fé e o equilíbrio do ajuste, porquanto importa restrição a direitos fundamentais próprios da natureza e da finalidade do contrato (direito à vida e à saúde).

Em se tratando de exclusão de cobertura, ela não pode ser estatuída de modo residual, ou seja, sob o raciocínio de que o que não está previsto está excluído. Do contrário, arrogar-se-ia a operadora na prerrogativa de controlar casuisticamente extensão de sua obrigação, autorizando ou negando cobertura de forma arbitrária e abusiva.

Portanto é de rigor a obrigatoriedade do plano do autor custear e realizar o procedimento/medicamento requerido.

Por seu turno, no que diz respeito à **indenização por danos morais,** vê-se que a relação que une as partes está submetida às regras de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e, em se tratando de contrato de adesão, sua interpretação deve ser direcionada a compreendê-lo da forma mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), sobretudo diante da realidade narrada nos presentes autos, vez que, os princípios e preceitos insculpidos no mencionado Diploma, derrogam as disposições contratuais que com eles colidirem.

O dano moral consiste na lesão a um interesse ou bem juridicamente protegido e seu ressarcimento visa a uma satisfação extrapatrimonial do indivíduo. Justamente por não serem passíveis de aferição econômica, a prestação pecuniária, em caso de lesão a algum destes bens, tem função meramente satisfatória, procurando compensar, até certo ponto, o dano injusto pelas vantagens e satisfação que o dinheiro poderá proporcionar.

Assim, considerando que o dano moral, neste caso, embora não tenha como foco a honra ou imagem da vítima, decorre do mal físico que lhe foi causado, torna-se prudente convir que a situação do autor diante da negativa da ré não se configurou compatível com a necessidade de seu tratamento.

## DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Como sabido, o arbitramento do dano moral é fixado pelo julgador, utilizando-se, para tanto, do critério da fixação equitativa, tendo em vista a repercussão do dano, a intensidade do dolo ou culpa, bem como a possibilidade econômica das partes.

A indenização deverá ser proporcional ao dano sofrido (art. 944 do Código Civil), com as seguintes finalidades: a) compensatória à vítima pela lesão à honra e à integridade moral, não se permitindo que o dano seja fonte de lucro; b) pedagógica, com o fito de evitar que condutas abusivas sejam novamente praticadas em detrimento de outros consumidores.

Por conseguinte, em casos como tais, deve o julgador utilizar o critério da razoabilidade, aferindo as causas e consequências do ato ilícito.

Face ao exposto, e atento a tudo o mais que dos autos consta, com base no art. 487, I do Código de Ritos, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito para:

**- CONFIRMAR,** e tornar definitiva, a decisão que deferiu a tutela de urgência id. 149137192, ***caso ainda não o tenha feito***;

**- CONDENAR** a Demandada, consoante textualizado nos fundamentos desta decisão, a pagar ao demandante, à título de compensação por danos morais, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser corrigido com base na tabela do ENCOGE, tendo-se por termo a quo a data da presente decisão (Enunciados das Súmulas n. 362 e 160 do STJ e do TJPE, respectivamente); cominando-se, ainda, juros de mora no percentual de 1% (art. 406 do CC em vigor e a sua combinação com o art. 161, § 3º, do CTN), tendo-se por termo inicial a data da citação;

**Registre-se que a obrigação do réu deverá ser cumprida mediante a apresentação, *periódica*, de prescrição médica atualizada, comprovando a necessidade de continuação do uso da medicação, a fim de que seja impedido qualquer desvio de finalidade no fornecimento do fármaco em questão, protegendo a finalidade pública da presente decisão.**

**- CONDENAR** a demandada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sendo que estes, por força do art. 85, §2º, I a IV, do novel Código de Processo Civil, arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

No caso de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada, por intermédio de seus advogados/procuradores para, no prazo de 15 (quinze) dias (a teor do art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil), apresentar, querendo, contrarrazões.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação da resposta, remetam-se os autos à instância superior, com as nossas homenagens, e após as baixas necessárias na Distribuição, independentemente de novo comando judicial.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Contador do Juízo a fim de que seja verificada a existência de custas processuais pendentes. Em havendo, intime-se a parte Devedora para o recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 20% sobre o valor do débito, nos termos do Art.22, da Lei 17.116/2020.

No caso de inércia, remetam-se ao Comitê Gestor de Arrecadação/Procuradoria Geral do Estado, conforme seja o caso, a documentação listada no Art. 27, §3º, da Lei 17.116/2020, a fim de que sejam adotadas as providências que

entender, inclusive o protesto do título judicial e à inclusão do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sem prejuízo da cobrança judicial do débito.

Uma vez cumpridas todas as formalidades legais, remetam-se ao arquivo.

Recife- PE, data e assinatura eletrônicas.

MARCO AURÉLIO MENDONÇA DE ARAÚJO - Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: MARCO AURELIO MENDONCA DE ARAUJO
09/04/2024 11:55:21
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 162400912

24040911552131800000158631446

IMPRIMIR GERAR PDF